

吐加紫苏叶、黄连,或加竹茹、藿香;尿酸高加猫爪草、秦艽、秦皮、山慈菇,或加穿山龙、土鳖虫、豨莶草、蜂房;气虚加人参、黄芪;阳虚加小茴香、肉桂,或加巴戟天、淫羊藿、附子、干姜;阴虚加龟甲胶、黑芝麻;肾虚加山药、山茱萸、生地黄,或加桑寄生、杜仲;血瘀加桃仁、红花;口干口渴加葛根、地骨皮、玉竹、黄连;眠差加柏子仁、首乌藤、酸枣仁;汗出加浮小麦、麻黄根;浮肿或小便不利加茯苓、车前子、泽泻,或加薏苡仁;纳差加焦山楂、焦六神曲、炒麦芽,或加炒鸡内金,或加焦栀子;眼干加青箱子、决明子。

得出聚类核心组合 26 条(表 4、表 5)。可以看出南征教授治疗“消渴肾衰”的隐形用药药对组合和核心药物组合,体现了南征教授治疗本病的诸多自拟方剂中临床常用方剂的核心配伍。

得出新方组合 13 条(表 6)。其中新方竹茹、槟榔、草果、山慈菇、土鳖虫、豨莶草、泽泻组合,主要侧重于清热利湿,解毒通络,因此可以将该新方组合应用于湿热蕴结等证,但是否能达到疗效的最大化和最优化还有待于到临床中去实践和验证。

参考文献:

- [1] 南征,南红梅. 治疗消渴就是打败糖尿病 [M]. 长春:吉林科学技术出版社,2018:98-100.

- [2] 国家中医药管理局医政司. 中国标准书号: GB/T 16751.1-1997. 中医临床诊疗术语疾病部分 [J]. 北京:国家技术监督局,1997.
- [3] 郑筱萸. 中药新药临床研究指导原则(试行) [M]. 北京:中国医药科技出版社,2002.
- [4] 李灿东,吴承玉. 中医诊断学 [M]. 北京:中国医药科技出版社,2012.
- [5] 钟赣生. 中药学 [M]. 北京:中国医药科技出版社,2012.
- [6] 吴勉华,王新月. 中医内科学 [M]. 北京:中国医药科技出版社,2018.
- [7] 高彦彬,刘铜华,李平. 糖尿病肾病中医防治指南 [J]. 中国中医药现代远程教育,2011,9(4):151-153.
- [8] 杨甲录. 新药(中药)治疗消渴病(糖尿病)临床研究的技术指导原则 [J]. 中国医药学报,1990(4):76-77.
- [9] 何立群,许筠,孙伟,等. 慢性肾衰竭诊疗指南 [J]. 中国中医药现代远程教育,2011,9(9):132-133.
- [10] 中华医学会糖尿病学分会. 中国 2 型糖尿病防治指南(2017 年版) [J]. 中华糖尿病杂志,2018,10(1):4-67.
- [11] 中华医学会糖尿病学分会微血管并发症学组. 中国糖尿病肾脏疾病防治临床指南 [J]. 中华糖尿病杂志,2019(1):1528.

收稿日期:2021-02-02

• 临床报道 •

理气健脾化痰法对痰湿体质患者 Hcy、UA 近远期疗效观察*

段传皓

(北京市海淀区中医医院,北京 100086)

摘要 目的:观察理气健脾化痰法中药代茶饮对痰湿体质患者血清同型半胱氨酸(Hcy)、尿酸(UA)的影响。方法:选取2017年1月—2019年12月北京市海淀区中医医院门诊收治的高同型半胱氨酸血症(HHcy)、高尿酸血症(HUA)的痰湿体质患者100例,随机分为对照组和治疗组各50例。对照组给予苯溴马隆片50mg+叶酸片0.8mg,每日1次,口服,治疗组给予理气健脾化痰法中药代茶饮。经治2月,观察两组患者的近远期疗效。结果:两组近期有效率及治疗后的中医证候积分相当($P>0.05$);两组患者血清Hcy、UA较治疗前均有降低($P<0.05$),但组间比较差异无统计学意义($P>0.05$);治疗组远期疗效优于对照组($P<0.05$),复发率低,且无副作用。结论:理气健脾化痰法中药代茶饮可以降低Hcy、UA水平,远期疗效好,复发率低,不良反应少。

关键词 理气健脾化痰法;痰湿体质;高尿酸血症;高脂血症;临床观察

中图分类号 R 242 **文献标志码** A **文章编号** 1002-1078(2021)06-0030-03

DOI:10.13913/j.cnki.41-1110/r.2021.06.011

高同型半胱氨酸血症(HHcy)、高尿酸血症(HUA)是临床常见病和多发病,近年来研究发现,痰湿体质患者多伴有该症^[1-3]。正常人空腹血浆中

同型半胱氨酸(homocysteine, Hcy)含量为5~15 $\mu\text{mol/L}$,如果超过这个范围,就被称之为HHcy,现代医学通过补充叶酸降低其水平。在正常嘌呤摄入状态下,非同日2次肾功能检查,其中绝经后女性和男性空腹尿酸水平 $>420\mu\text{mol/L}$ 、非绝经期女性空腹尿酸水平 $>360\mu\text{mol/L}$ 被定义为HUA^[4],现代

* 基金项目:北京中医药薪火传承“3+3”工程项目(2012-JC-02)。

医学给予口服叶酸片、苯溴马隆片治疗,效果确切,但停药后容易反复。本文应用理气健脾化痰法对痰湿体质 HHcy、HUA 患者进行干预治疗,观察理气健脾化痰中药代茶饮对 Hcy、UA 的近远期疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取 2017 年 1 月—2019 年 12 月北京市海淀区中医医院门诊收治的 HHcy、HUA 的痰湿体质患者 100 例,随机分为对照组和治疗组各 50 例。观察过程中治疗组脱落 4 例,对照组脱落 3 例。治疗组中 46 例中,男 24 例,女性 22 例;年龄 33~80 岁,平均(63.12±12.89)岁;伴有高血压病者 23 例,糖尿病者 31 例,冠心病者 16 例。对照组 47 例中,男 23 例,女 24 例;年龄 32~79 岁,平均(62.92±12.76)岁;伴有高血压病者 22 例,糖尿病患者 30 例,冠心病者 17 例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义($P>0.05$),具有可比性。

1.2 诊断标准 根据王琦教授《中医体质学》,参照《中医病证诊断疗效标准》^[5]、《中药新药临床研究指导原则(试行)》^[6],痰湿体质诊断标准:①头重如裹,口中黏腻;②纳谷不馨,食后腹胀;③肢体困乏,大便黏滞;④脉濡或滑,舌胖苔腻。符合其中 3 条(其中第 4 条必备)即为痰湿体质。Hcy $\geq 15\text{ }\mu\text{mol/L}$,男性和绝经后女性 UA $>420\text{ }\mu\text{mol/L}$,非绝经期女性 $>360\text{ }\mu\text{mol/L}$ 。

1.3 纳入标准 ①符合上述诊断标准者;②年龄 31~80 岁;③表述能力强,依从性较好;④同意纳入本次研究,且患者本人签署知情同意书备案。

1.4 排除标准 ①不符合上述纳入标准者;②痛风急性发作者;③已服用降尿酸药和叶酸片者;④甲状腺功能亢进或甲状腺机能减退,慢性肾病患者;⑤妊娠及哺乳期妇女;⑥严重精神病患者。

2 治疗方法

2.1 对照组 给予叶酸片(北京麦迪海药业有限责任公司,国药准字 H 11020317) 0.8 mg,苯溴马隆片(宜昌长江药业有限公司,商品名:尔同舒,国药准字 H 20040348) 50 mg,每日 1 次,口服。

2.2 治疗组 给予理气健脾化痰法,选用中药代茶饮治疗。药物组成:陈皮 6 g,玫瑰花 6 g,泽泻 6 g,红曲 6 g。水煎,每日至少饮 2000 mL。

两组疗程均为 2 月,疗程结束,评定近期疗效;停药 6 月后,评定远期疗效。

3 疗效观察

3.1 观察指标 观察两组患者近期疗效,治疗前后血清 Hcy 和 UA 水平变化情况,治疗前后中医证候积分改善情况,远期疗效,以及不良反应发生情况。

3.2 疗效标准 近期疗效:以患者症状、体征基本消失,Hcy、UA 恢复正常,或较治疗前降幅 $\geq 80\%$ 为治愈;症状、体征有所好转,Hcy、UA 有所降低, $30\% \leq$ 较治疗前降幅 $<80\%$ 为有效;症状、体征无改善或加重,Hcy、UA 虽有下降但较治前降幅不足 30%或者升高为无效。

远期疗效:针对痊愈者进行评价。以停药后无异常症状、体征,第 6 个月复查 Hcy、UA 指标正常者为长期缓解;停药后 3 月 $\leq$ 异常症状、体征出现时间 <6 月,复查 Hcy、UA 指标异常为中期缓解;停药后 1 月 $\leq$ 异常症状、体征出现时间 <3 月,复查 Hcy、UA 指标异常为短期缓解;停药后 1 个月内出现异常症状、体征,复查 Hcy、UA 化验指标异常者为复发。

中医证候评分:根据《中药新药临床研究指导原则(试行)》进行中医症状量化分级,轻度计 1 分,中度计 2 分,重度计 3 分。①头重如裹、口中黏腻:头重如戴帽而紧,眩晕欲仆,不能站立,口苦口中异味,痰涎壅盛者为重度;微觉头沉,头晕眼花,时作时止,口微黏腻欲漱者为轻度;症状介于轻度及重度之间者为中度。②纳谷不馨,食后腹胀:持续脘闷腹胀者为重度;食后脘闷腹胀,2 h 内自行缓解,症状介于轻度及重度之间者为中度;食后脘闷腹胀,半小时内自行缓解,食欲较差,食量减少低于 1/3 者为轻度。③肢体困乏,大便黏滞:困重明显,不欲活动,大便黏腻者为重度;稍觉困重,不影响活动者为轻度;病情介于轻度及重度之间者为中度。④脉滑或濡,舌苔厚腻:脉滑数,苔厚腻者为重度;脉濡,苔白微腻者为轻度;病情介于轻度及重度之间者为中度。

安全性指标:治疗前后监测患者肝、肾功能,服药期间每周定期随访,并观察记录有无药物过敏、恶心、腹泻、皮肤瘙痒等不良反应。

3.3 统计学方法 采用 SAS 8.2 软件包进行统计分析。计数资料以例(%)表示,采用 χ^2 检验,计量资料以均数 $\pm$ 标准差($\bar{x} \pm s$)表示,采用配对 t 检验。以 $P<0.05$ 表示差异有统计学意义。

3.4 治疗结果 见表 1~表 4。

表 1 两组 HHcy、HUA 痰湿体质患者近期临床疗效比较 例(%)

组别	例数	治愈	显效	无效	总有效
治疗组	46	21(45.65)	14(30.43)	11(23.91)	35(76.09)*
对照组	47	26(55.32)	16(34.04)	5(10.64)	42(89.36)

注: * $P=0.0899$ 。

表 2 两组 HHcy、HUA 痰湿体质患者治疗前后血清 Hcy、UA 变化情况 $\mu\text{mol/L}$, ($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	Hcy		UA	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
治疗组	46	26.10 $\pm$ 6.03	11.93 $\pm$ 3.74*	436.20 $\pm$ 68.09	362.63 $\pm$ 55.25*
对照组	47	24.08 $\pm$ 5.20	15.25 $\pm$ 5.41*	438.15 $\pm$ 59.99	347.68 $\pm$ 46.08*
t 值		1.6100	8.3900	-0.1500	1.4200
P 值		0.1119	0.0038	0.8836	0.1596

注:与组内治疗前比较,* $P < 0.05$ 。

表 3 两组 HHcy、HUA 痰湿体质患者治疗前后
中医证候积分比较 分, ($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	治疗前	治疗后	t 值	P 值
治疗组	46	5.80 $\pm$ 1.53	2.39 $\pm$ 2.19	8.68	<0.001
对照组	47	5.60 $\pm$ 1.48	2.15 $\pm$ 2.28	8.68	<0.001
t 值				0.6700	0.8625
P 值				0.5062	0.3500

表 4 两组 HHcy、HUA 痰湿体质患者远期
临床疗效比较 例 (%)

组别	例数	长期缓解	中期缓解	短期缓解	复发
治疗组	21	11(52.38)	7(33.33)	3(14.29)	0(0.00)*
对照组	26	6(23.08)	8(30.77)	7(26.92)	5(19.23)

注:* $P = 0.0429$ 。

3.5 不良反应发生情况 治疗前后两组患者均未见肝功能、肾功能异常,对照组有 5 例患者出现恶心、腹泻,3 例皮肤瘙痒,治疗组患者无不适感受。

4 讨论

《泰定养生主论》云“父母俱有痰疾,我稟此疾,则与生俱生也。”^[7]指出了痰湿体质与生俱来,与先天禀赋关系密切。《杂病源流犀烛》云“由于脾胃寒湿生痰,或饮啖过度,好食酒面猪脂,以致脾气不利,壅滞为痰。”^[8]指出后天饮食不节,脾胃功能失调,也会形成痰湿体质。有研究发现,同型半胱氨酸的中医属性为湿^[9]。因此改善痰湿体质,对于 HHcy 和 HUA 的治疗有积极意义。

中医认为,湿为阴邪,且湿性黏滞,张仲景言“病痰饮者,当以温药和之”。故笔者认为,改善痰湿体质,遣药组方首先要以暖药为主,凉药为辅,其次应当从调整脾胃升降入手,补气健脾,化湿消滞。

本次研究选用的理气健脾化痰法中药代茶饮由陈皮、泽泻、玫瑰花、红曲组成。其中,陈皮性温,味辛、苦,归脾肺经,有燥湿理气、健脾化痰之功,主治纳呆食少,腹满吐泻,痰多咳嗽。泽泻味甘、淡,性寒,入肾、膀胱经,有利水、渗湿、泄热之功。玫瑰花味甘、微苦,性温,归肝脾经,有行气解郁、和血散瘀之功。红曲味甘,性微温,有健脾活血、消食化瘀之功,主治饮食积滞,脘腹胀满,跌打损伤,赤白下痢,

妇人产后恶露不尽等。

代茶饮药仅四味,但其中寒温相配,久服不至于寒凉伤胃;血不利则为水,故化湿中兼有化瘀;全方位顾护中焦脾胃,以理气健脾为根本,兼有化湿逐瘀、解毒消痰之功。

针对 HHcy,本研究选用叶酸片 0.8 mg/d 来控制血清 Hcy。针对 HUA,研究显示^[10],苯溴马隆在治疗 HUA 方面与别嘌醇相当,但不良反应较少,因此本研究选用 50 mg/d 苯溴马隆片进行治疗。

本研究结果显示,对于痰湿体质 HHcy 和 HUA 患者,采用理气健脾化痰法中药代茶饮,其近期疗效、Hcy、UA 改善情况与单用西药的对照组相当,但在远期疗效上,治疗组优于对照组($P < 0.05$)。

参考文献:

- [1] 李海昌,温成平,谢志军.痰湿体质与痛风及高尿酸血症的相关性探讨[J].中华中医药学刊,2013,31(4):841-842.
- [2] 姚海强,李玲孺,王济,等.从痰湿体质角度探讨高同型半胱氨酸血症的防治[J].环球中医药,2016,9(6):715-717.
- [3] 杨敏春,张伟娟,李蒙智,等.534 例高脂血症体检者中医体质分布及合并高尿酸血症分析[J].中华中医药学刊,2017,35(4):984-988.
- [4] 中国医师协会肾脏内科医师分会.中国肾脏疾病高尿酸血症诊治的实践指南(2017 版)[J].中华医学杂志,2017,97(25):1927-1936.
- [5] 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,1994:23.
- [6] 郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行)[M].北京:中国医药科技出版社,2002:73.
- [7] 王珪.泰定养生主论[M].北京:学苑出版社,2003:157.
- [8] 沈金鳌.杂病源流犀烛[M].北京:中国中医药出版社,1994:250.
- [9] 柳鹏飞.加味二陈汤对稳定型心绞痛(痰浊内阻)伴高 Hcy 血症的临床观察[D].哈尔滨:黑龙江中医药大学,2017:27.
- [10] 邵莉,魏丽.苯溴马隆与别嘌醇治疗原发性痛风高尿酸血症疗效与安全性比较的 Meta 分析[J].中国循证医学杂志,2012,12(6):722-726.

收稿日期:2021-01-24